Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Paukenröhrchen-Einlage / Parazentese

Einsetzen von Paukenröhrchen in das Trommelfell / Eröffnung des Trommelfells zum Absaugen von Flüssigkeit

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Seite: ☐ Rechts ☐ Links ☐ Beidseits

Geplanter Eingriff: ☐ Parazentese + Paukenröhrchen ☐ Nur Parazentese (ohne Röhrchen)

Art des Röhrchens: ☐ Kurzzeit-Röhrchen ☐ Langzeit-Röhrchen (T-Röhrchen o. Ä.) _____

Zusätzliche Eingriffe in derselben Sitzung: ☐ Adenotomie ☐ Tonsillektomie ☐ Keine _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Das Mittelohr ist ein kleiner Raum hinter dem Trommelfell, der normalerweise mit Luft gefüllt ist. Es wird über die **Ohrtrompete (Tuba Eustachii)** belüftet, die in den hinteren Nasenraum mündet. Funktioniert die Ohrtrompete nicht gut (besonders bei Kindern, etwa wegen einer vergrößerten Rachenmandel, einer Allergie oder häufiger Erkältungen), **sammelt sich Flüssigkeit** im Mittelohr an („Paukenerguss“).

Diese Flüssigkeit kann zu **Schwerhörigkeit**, bei Kindern zu einer **verzögerten Sprech- und Sprachentwicklung**, zu Aufmerksamkeitsproblemen, Gleichgewichtsstörungen und **wiederholten Mittelohrentzündungen** führen. Bleibt die Flüssigkeit lange bestehen, kann das Trommelfell dünn werden, sich einziehen und sich dauerhaft verändern. Ähnliche Probleme können auch bei Erwachsenen auftreten, zum Beispiel durch Druckprobleme nach Flügen oder Tauchgängen oder wegen Erkrankungen im hinteren Nasenraum.

Ziel dieses Eingriffs ist es, eine kleine Öffnung im Trommelfell anzulegen, um die Flüssigkeit abzulassen, und mit einem darin eingesetzten kleinen Röhrchen die Belüftung des Mittelohrs aufrechtzuerhalten – **um das Hören zu verbessern und die Häufigkeit von Entzündungen zu verringern.**

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Bei Kindern wird der Eingriff in der Regel in einer kurzen Vollnarkose durchgeführt, bei Erwachsenen meist in örtlicher Betäubung. Er erfolgt durch den Gehörgang unter dem Mikroskop; **es gibt keine Schnitte oder Narben von außen.**

1. **Reinigung des Gehörgangs:** Unter dem Mikroskop wird eventuell vorhandenes Ohrenschmalz aus dem Gehörgang entfernt und das Trommelfell untersucht.
2. **Parazentese:** In einen Bereich des Trommelfells, in dem das Hören nicht beeinträchtigt wird, wird ein kleiner Schnitt von etwa 1–2 mm gesetzt.
3. **Absaugen der Flüssigkeit:** Die Flüssigkeit im Mittelohr (sie kann klar, zäh oder eitrig sein) wird mit einem feinen Sauger entfernt. Bei Bedarf kann eine Probe für eine Kultur (Erregernachweis) entnommen werden.
4. **Einsetzen des Röhrchens:** Ein winziges, garnrollenförmiges Röhrchen von wenigen Millimetern Größe wird in die Öffnung eingesetzt. Dieses Röhrchen übernimmt vorübergehend die Aufgabe der Ohrtrompete und hält das Mittelohr belüftet.
5. **Abschluss:** Bei Bedarf werden Ohrentropfen gegeben. In der Regel wird keine Tamponade in das Ohr gelegt, allenfalls ein kleines Stück Watte.

Kurzzeit-Röhrchen werden in der Regel innerhalb von **6–18 Monaten** im Zuge der Heilung des Trommelfells von selbst abgestoßen und fallen in den Gehörgang; dies bleibt oft unbemerkt. **Langzeit-Röhrchen** verbleiben länger und müssen manchmal in einem gesonderten Eingriff entfernt werden.

Wird nur eine Parazentese durchgeführt (ohne Röhrchen), schließt sich die Öffnung im Trommelfell innerhalb weniger Tage, und es kann sich erneut Flüssigkeit ansammeln.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Bei Kindern Vollnarkose; bei Erwachsenen meist örtliche Betäubung	Etwa 10–20 Minuten für beide Ohren	In der Regel Entlassung am selben Tag

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Das Hören verbessert sich meist sofort oder innerhalb kurzer Zeit
- Bei Kindern ein positiver Einfluss auf Sprechen, Sprachentwicklung, Aufmerksamkeit und Schulleistungen
- Weniger und mildere Mittelohrentzündungen; tritt doch eine Entzündung auf, kann sie meist mit Ohrentropfen statt mit Antibiotika zum Einnehmen behandelt werden
- Geringeres Risiko bleibender Schäden am Trommelfell; Linderung von Druck- und Völlegefühl im Ohr

Solange das Röhrchen sitzt und durchgängig ist, verbessert sich bei der großen Mehrzahl der Patientinnen und Patienten das Hören, und Mittelohrentzündungen werden seltener. Ist die Ohrtrompete bis zum Herausfallen des Röhrchens ausreichend ausgereift, kehrt die Flüssigkeit meist nicht zurück. Bei manchen Kindern (etwa **20–30 von 100**) sammelt sich jedoch erneut Flüssigkeit an, und **weitere Röhrchen** können notwendig werden.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Abwartendes Beobachten:** Bei vielen Kindern verschwindet die Flüssigkeit im Mittelohr innerhalb von 3 Monaten von selbst. Ist die Schwerhörigkeit gering und bestehen keine Risikofaktoren, ist eine Beobachtung mit regelmäßigen Hörtests möglich.
- **Autoinflation:** Besonders bei älteren Kindern kann das Aufblasen eines speziellen Ballons über die Nase helfen, die Ohrtrompete zu öffnen.
- **Hörgeräte:** Für Patientinnen und Patienten, die keine Operation wünschen oder für die sie nicht geeignet ist, können sie eine vorübergehende Lösung sein, solange die Flüssigkeit besteht.
- **Medikamente:** Eine Allergie oder eine Erkrankung von Nase und Nasennebenhöhlen wird, falls vorhanden, behandelt; es gibt jedoch nur begrenzte Belege dafür, dass Antibiotika, Kortison oder Nasensprays die Flüssigkeit im Mittelohr dauerhaft beseitigen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Adenotomie:** Kann bei geeigneten Kindern zusammen mit den Röhrchen oder dann empfohlen werden, wenn weitere Röhrchen notwendig werden.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne den Eingriff kann die Flüssigkeit bei manchen Patientinnen und Patienten von selbst verschwinden; bleibt sie jedoch bestehen, können Schwerhörigkeit, bei Kindern eine verzögerte Sprech- und Sprachentwicklung, Aufmerksamkeits- und Schulprobleme, Gleichgewichtsstörungen und wiederholte Mittelohrentzündungen fortbestehen. Eine lange bestehende Flüssigkeitsansammlung kann zu einer Einziehung des Trommelfells (Retraktion), bleibenden Trommelfellveränderungen, Schäden an den Gehörknöchelchen und selten zu schwereren, operationsbedürftigen Ohrerkrankungen wie einem **Cholesteatom** führen.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor dem Eingriff werden ein Hörtest (Audiometrie) und eine Messung des Mittelohrdrucks (Tympanometrie) durchgeführt.
- Ist eine Vollnarkose geplant, werden Sie vom Narkosearzt untersucht; **6 Stunden** vor der Operation dürfen keine feste Nahrung und keine Milch gegeben werden, und für klare Flüssigkeiten gilt die vom Narkosearzt angegebene Zeit.
- Bitte teilen Sie uns Fieber, Husten oder eine Grippe in den 2 Wochen vor dem Eingriff mit; er kann dann verschoben werden.
- Bestehen Ohrenausfluss oder eine akute Entzündung, müssen diese möglicherweise vor dem Eingriff behandelt werden.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Tag des Eingriffs	Die meisten Patientinnen und Patienten gehen innerhalb weniger Stunden nach Hause. Leichte Ohrenschmerzen oder ein Druckgefühl können auftreten und klingen mit einfachen Schmerzmitteln ab. Einige Tage lang kann leicht blutige oder wässrige Flüssigkeit aus dem Ohr austreten. Die meisten Patientinnen und Patienten **hören Geräusche sofort lauter**; dies kann anfangs unangenehm sein.
Erste Woche	Falls Ihr Arzt es empfohlen hat, werden Ohrentropfen angewendet. Kinder können innerhalb von 1–2 Tagen wieder in die Schule oder den Kindergarten gehen, Erwachsene wieder arbeiten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Ohren gelangt.
4.–8. Woche	Es erfolgt die erste Kontrolluntersuchung; wir prüfen, ob das Röhrchen richtig sitzt und durchgängig ist, und der Hörtest wird wiederholt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Solange das Röhrchen liegt (6–18 Monate)	Kontrollen werden etwa **alle 3–6 Monate** empfohlen. Eine Mittelohrentzündung zeigt sich durch Ausfluss und wird meist mit Ohrentropfen behandelt. Fliegen ist mit liegendem Röhrchen in der Regel angenehmer.
Nach dem Herausfallen des Röhrchens	Das Trommelfell wird kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich das Loch geschlossen hat und keine Flüssigkeit im Mittelohr ist; es wird ein Hörtest durchgeführt.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Leichte Ohrenschmerzen und Druckgefühl (1–2 Tage)
- Einige Tage lang leicht blutige oder wässrige Absonderung aus dem Ohr
- Geräusche erscheinen vorübergehend sehr laut oder hallend
- Vorübergehende Übelkeit oder Unruhe nach einer Vollnarkose

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Ohrenausfluss (Otorrhö)** — Etwa **10–25 von 100** Patientinnen und Patienten mit Röhrchen haben mindestens einmal Ohrenausfluss, meist nach einer Erkältung oder wenn Wasser ins Ohr gelangt ist. Er klingt meist innerhalb weniger Tage mit antibiotischen Ohrentropfen ab. Selten kann der Ausfluss hartnäckig sein und Medikamente zum Einnehmen, eine Reinigung des Ohres oder die Entfernung des Röhrchens erfordern.
- **Weiße Flecken auf dem Trommelfell (Tympanosklerose)** — Kalkartige weiße Flecken auf dem Trommelfell sind häufig (etwa **10–30+ von 100** Ohren). In den meisten Fällen beeinträchtigen sie das Hören nicht.
- **Vorzeitiges Herausfallen oder Verstopfen des Röhrchens** — Das Röhrchen kann früher als erwartet herausfallen oder durch eingetrocknetes Blut oder Sekret verstopfen. Es wird versucht, es mit Tropfen wieder durchgängig zu machen; falls nötig, wird das Röhrchen ersetzt.
- **Notwendigkeit weiterer Röhrchen** — Sammelt sich nach dem Herausfallen des Röhrchens erneut Flüssigkeit an, benötigen etwa **20–30 von 100** Kindern ein zweites Paar Röhrchen (manchmal zusammen mit einer Entfernung der Rachenmandel).

Gelegentliche Beschwerden

- **Bleibendes Loch im Trommelfell (Perforation)** — Nach dem Herausfallen des Röhrchens kann sich das Loch im Trommelfell nicht schließen: bei Kurzzeit-Röhrchen bei etwa **1–3 von 100** Patientinnen und Patienten, bei Langzeit-Röhrchen häufiger (bei etwa **10–20 von 100**). Kleine Löcher verursachen oft keine Beschwerden; führen sie zu wiederkehrendem Ausfluss oder Schwerhörigkeit, kann **ein Verschluss durch eine gesonderte Operation (Tympanoplastik/Myringoplastik)** notwendig werden.
- **Ausdünnung oder Einziehung des Trommelfells** — Das Trommelfell kann an der Stelle, an der das Röhrchen saß, dünn werden oder sich nach innen einziehen; Kontrollen können notwendig sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Röhrchen fällt nicht heraus** — Fällt das Röhrchen nicht in der erwarteten Zeit heraus (meist, wenn es länger als 2–3 Jahre liegt), muss es möglicherweise in einem kurzen Eingriff entfernt werden; bei Kindern geschieht dies in der Regel in Vollnarkose.
- **Gewebewucherung im Gehörgang (Granulation)** — Um das Röhrchen kann sich rotes, entzündetes Gewebe bilden; es kann blutigen Ausfluss verursachen und wird mit Tropfen oder einem kleinen Eingriff behandelt.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Röhrchen gelangt ins Mittelohr** — Sehr selten kann das Röhrchen, statt herauszufallen, hinter das Trommelfell ins Mittelohr rutschen; zur Entfernung kann ein gesonderter Eingriff notwendig sein.
- **Cholesteatom** — Eine zystenartige Erkrankung, die entsteht, wenn die Hautschicht des Trommelfells in das Mittelohr hineinwächst. Sie steht **sehr selten** im Zusammenhang mit einer Röhrcheneinlage. Tritt sie auf, ist eine operative Behandlung erforderlich.
- **Hörverlust, Ohrgeräusche (Tinnitus) oder Schwindel** — Ein bleibender Hörverlust, Tinnitus oder Schwindel durch eine Beteiligung des Innenohrs oder der Gehörknöchelchen ist **äußerst selten**.
- **Verletzung des Gehörgangs und Blutung** — In engen Gehörgängen können kleine Verletzungen auftreten; sehr selten wurden schwere Verletzungen im Zusammenhang mit anatomischen Varianten des Gesichtsnervs, des Innenohrs oder großer Blutgefäße berichtet.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- Starker oder übel riechender Ohrenausfluss, der trotz Tropfen **länger als 3–5 Tage** anhält
- **Fieber über 38,5 °C**, starke Ohrenschmerzen
- Rötung oder Schwellung hinter dem Ohr oder ein nach vorne abstehendes Ohr
- **Plötzlicher Hörverlust**, starker Schwindel, Gangunsicherheit oder Erbrechen
- Asymmetrie des Gesichts, herabhängender Mundwinkel oder Unfähigkeit, das Auge zu schließen
- Starke Blutung aus dem Ohr

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Solange das Röhrchen liegt, **vermeiden Sie, dass verschmutztes Wasser (Seen, Meer, Schwimmbad, Badewasser) ins Ohr gelangt.** Beim Duschen und Baden können mit Vaseline getränkte Watte oder Ohrstöpsel verwendet werden. Befolgen Sie beim Schwimmen den Rat Ihres Arztes; Schwimmen an der Wasseroberfläche mit Ohrstöpseln und/oder Badekappe ist in der Regel erlaubt, Tauchen wird jedoch nicht empfohlen.
- Reinigen Sie den Gehörgang nicht von innen mit Wattestäbchen.
- Tritt Ohrenausfluss auf, wischen Sie ihn von außen vorsichtig ab, verwenden Sie die Ihnen empfohlenen Tropfen und informieren Sie Ihren Arzt. Verwenden Sie keine anderen Ohrentropfen eigenmächtig; manche Tropfen sind für das Mittelohr nicht geeignet.
- Nehmen Sie die Kontrolltermine auch nach dem Herausfallen des Röhrchens weiterhin wahr; es ist wichtig, das Hören und den Zustand des Trommelfells zu überwachen.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.
- ☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.

☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.

☐ Mir ist bewusst, dass das Röhrchen nach einer gewissen Zeit von selbst herausfällt, dass weitere Röhrchen notwendig werden können, wenn sich erneut Flüssigkeit ansammelt, und dass, falls ein bleibendes Loch im Trommelfell zurückbleibt, eine gesonderte Operation zu dessen Verschluss notwendig werden kann.

☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**

☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.